

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer normas e procedimentos para a realização do Controle Interno de Qualidade, assim como a avaliação dos resultados, critérios de aprovação dos mesmos e a implementação de ações necessárias caso um controle ou analito não seja aprovado, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☐	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002 – Exames
4.3. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos
4.4. ITS008- Controle interno
4.5. PQ009- Controle Interno de Qualidade
4.6. PQ015 – Biossegurança
4.7. PQ041- Descarte de Resíduos e Rejeitos
4.8. PQQUA016- Análise crítica do desempenho do sistema da qualidade

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026

Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026

- 5.1. CIQ – Controle interno de qualidade
- 5.2. CEQ – Controle externo de qualidade
- 5.3. PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade
- 5.4. AMC – Amostra Controle
- 5.5. VHS – Velocidade de Hemossedimentação
- 5.6. CAL – Calibrador
- 5.7. DPO – Duplo Observador
- 5.8. CV – Coeficiente de Variação
- 5.9. DP – Desvio Padrão
- 5.10. NC – Não Conformidade
- 5.11. TAD – Teste de Aglutinação Direto
- 5.12. PAI – Pesquisa de Anticorpos Irregulares

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

6.1. O Controle Interno da Qualidade é um processo estatístico utilizado para monitorar os processos analíticos. Consiste na análise diária dos analitos, utilizando-se amostras controle com valores conhecidos para avaliar a precisão e exatidão dos ensaios. Através do Controle Interno pode-se avaliar e monitorar funcionamento confiável e eficiente dos procedimentos laboratoriais para fornecer resultados válidos, que possam contribuir eficazmente no estabelecimento do diagnóstico clínico, com finalidade de garantir a reprodutibilidade, verificar a calibração dos sistemas analíticos e indicar o momento de se promover ações corretivas quando necessário, levando-se em conta os critérios de aprovação dos controles que serão abordados a seguir.

6.1.1. **CV**= Coeficiente de variação: a razão entre o desvio padrão e a média expressa em porcentagem (exatidão)

6.1.2. **DP**= Desvio padrão: uma estatística que quantifica a dispersão dos valores dentro de uma série específica de valores (precisão)

6.2. APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS:

6.2.1. O controle interno de qualidade é aplicável a todos os setores do laboratório clínico, sendo estes:

- 6.2.1.1. Bioquímica
- 6.2.1.2. Hematologia/Imunohematologia
- 6.2.1.3. Parasitologia/Urinalise
- 6.2.1.4. Imunologia
- 6.2.1.5. Microbiologia

6.3. BIOQUÍMICA:

6.3.1. Bioquímica geral

6.3.1.1. A bioquímica é controlada internamente diariamente, através de uma amostra controle fornecida comercialmente, em dois níveis (normal e alterado) e verificando a sua reprodutibilidade e confiabilidade com a utilização de análise dos dados em gráfico de Levey-Jennings pelo próprio equipamento, analisado e interpretado seguindo as regras de Westgard.

6.3.1.2. O gráfico de Levey-Jennings, juntamente com as regras de Westgard garantem a confiança do processo.

6.3.1.2.1. Regras de Westgard:

6.3.1.2.1.1. Regra 1_{2s}: Regra de Advertência, utilizada para indicar uma medição de controle excedendo +/- 2DP.

6.3.1.2.1.2. Regra 2_{2s}: Regra de Rejeição, indica que dois controles utilizados excederam +/- 2DP, duas medições de controle consecutivas intra-ensaios ou inter-ensaios excederam o limite de +/- 2DP.

6.3.1.2.1.3. Regra 1_{3s}: Regra de Rejeição indica que uma medição de controle excedeu o limite de +/- 3DP

6.3.1.2.1.4. Regra R_{4s}: Regra de rejeição da corrida quando uma medição de controle, em uma mesma corrida, ficar a + 2DP e a outra medição -2DP e a diferença entre estas for maior que 4.

6.3.1.2.1.5. Regra 4_{1s}: Rejeita corrida analítica quando 4 medições consecutivas excederam o mesmo limite de + ou de - 2DP.

6.3.1.2.1.6. Regra 10X: Rejeita corrida analítica quando 10 medições consecutivas excederam o mesmo limite de + ou de - 2DP (do mesmo lado - tendência).

6.3.1.3. Amostras Controle:

6.3.1.3.1. Fornecidas pela Labtest, as amostras-controle necessitam de tratamento prévio pois chegam ao laboratório liofilizadas.

6.3.1.3.1.1. Utilizando luvas e EPI recomendável segundo o documento PQ015 - Biossegurança com uma pipeta graduada, adiciona-se gentilmente 5mL de água reagente (deionizada) ao frasco de controle liofilizado.

6.3.1.3.1.2. Mantendo o frasco em repouso, aguarda-se 20 minutos antes de homogeneizar a amostra para evitar formação de bolhas e partes não dissolvidas da amostra.

6.3.1.3.1.3. Após 20 minutos, homogeneiza-se gentilmente o frasco.

6.3.1.3.1.4. Divide-se a amostra controle em alíquotas menores de 400µL nos Eppendorfs, sendo utilizado de acordo com o ITE011 - .

6.3.1.3.1.5. Etiqueta-se a estante de amostra controle com validade de 15 dias a partir da data de preparo e armazena-as à -8°C.

6.3.1.4. Registro e Aprovação:

6.3.1.4.1. O colaborador responsável pelo setor, antes de liberar os resultados dos pacientes, faz uma avaliação dos valores obtidos no controle interno. São aprovados os controles que se encontrarem dentro de +/- 2 DP. Esses resultados devem ser registrados na planilha eletrônica FR006, que deve ser controlada diariamente e impressa ao final do mês.

6.3.1.4.2. – No caso em que os valores do analito específico da amostra controle, na avaliação do controle interno da qualidade estejam fora da variabilidade de ± 2 DP, avaliar se houve violação de alguma regra de Westgard. Se nenhuma regra foi violada, libera-se os resultados dos pacientes. Se a atual corrida violou alguma regra, abre-se um registro de “Não Conformidade”, FR003 e investiga-se as seguintes causas:

- 6.3.1.4.2.1.** Condição da água reagente do labmax-240
- 6.3.1.4.2.2.** Nível e meia vida do reagente em questão
- 6.3.1.4.2.3.** Validade da amostra controle
- 6.3.1.4.2.4.** Necessidade de calibração do reagente em questão
- 6.3.1.4.2.5.** Condições mecânicas e de software do equipamento labmax-240

6.3.1.4.3. Após constatar e corrigir o problema, realiza-se uma nova corrida com a amostra controle e se os resultados não violarem mais nenhuma regra de Westgard, registra-se na planilha eletrônica FR006 – CIQ de Bioquímica e libera-se os resultados dos pacientes.

6.3.1.4.4. Se a nova corrida ainda violar alguma regra, registra-se uma Não Conformidade e repete-se o processo descrito em 6.3.1.4.2 até que o problema seja corrigido.

6.4. HEMATOLOGIA/IMUNOHEMATOLOGIA:

6.4.1. Hematologia automatizada

6.4.1.1. A Hematologia automatizada é controlada diariamente através de amostra controle de 3 níveis comprada comercialmente pela ABX Horiba e da reprodutibilidade de uma amostra aleatória analisada do dia em comparação dos resultados com os equipamentos Cell Dyn Ruby e ABX PENTRA 60.

6.4.1.1.1. Os controles devem ser retirados da geladeira para que atinja temperatura ambiente e homogeneizado de forma adequada para a análise no equipamento Horiba ABX Pentra 60.

6.4.1.1.2. Passar as amostras controle no equipamento Horiba ABX Pentra 60.

6.4.1.1.3. Registrar os resultados na planilha de controle interno de hematologia FR006

6.4.1.1.4. No começo do dia, o colaborador escolhe uma amostra adequada para usar como controle para o dia.

6.4.1.1.5. Essa amostra é analisada pelo equipamento Cell Dyn Ruby e ABX PENTRA 60 e o resultado registrado no formulário de controle comparativo de amostra aleatória - FR008.

6.4.1.1.6. No dia seguinte, antes de iniciar a corrida analítica, ambienta-se o equipamento passando 3 amostras aleatórias.

6.4.1.1.7. Os controles deve ser retirados da geladeira para que atinja temperatura ambiente e homogeneizado de forma adequada para a análise no equipamento Horiba ABX Pentra 60.

6.4.1.1.8. Utilizando a amostra do dia anterior no aparelho, anota-se os valores obtidos na leitura na FR008 no campo correspondente.

6.4.1.1.9. Segue-se os passos descritos em 6.4.1.1.1 para a AMC do dia seguinte.

6.4.1.2. Registro e aprovação

6.4.1.2.1. Dentro da própria FR008, avalia-se a reprodutibilidade da amostra controle. Se o CV for igual ou menor que 10%, considera-se que a qualidade interna está conforme. Se algum valor exceder o CV de 10%, considera-se não conforme e registra-se uma NC na FR003. Nesse caso, realiza-se os seguintes passos:

6.4.1.2.1.1. Utilizando as instruções descritas na ITE001, realiza-se a limpeza leve do analisador hematológico ABX PENTRA 60 e no ITE002 analisador hematológico Ruby

6.4.1.2.1.2. Testa-se novamente a AMC e se o CV cair para dentro da faixa dos 10%, aceita-se a corrida analítica e dá-se sequência à rotina de análise dos pacientes.

6.4.1.2.1.3. Se ainda ficar fora do CV aceitável, realiza-se a limpeza pesada descrita na ITE001. Testa-se novamente a AMC e se o CV se tornar aceitável, dá-se sequência à rotina de análise dos pacientes.

6.4.1.2.1.4. Se ainda assim, a AMC permanecer fora do aceitável de 10%, é registrada uma não conformidade e aciona-se o auxílio da assistência técnica especializada.

6.4.2. Hematologia manual

6.4.2.1. Para maior controle e confiabilidade, realiza-se a leitura de lâminas manualmente para contagem diferencial leucocitária.

6.4.2.1.1. Realiza-se a confecção do esfregaço sanguíneo segundo ITA044

6.4.2.1.2. O primeiro observador realiza a contagem diferencial leucocitária segundo ITA044 e registra sua avaliação na FR007, no primeiro campo da amostra

6.4.2.1.3. O segundo observador realiza a contagem diferencial leucocitária segundo ITA044 das mesmas amostras observadas pelo primeiro colaborador e registra sua avaliação na FR007, no campo abaixo de cada lâmina correspondente.

6.4.2.2. Registro e aprovação

6.4.2.2.1. De todas as amostras analisadas na rotina diária, no mínimo 10% são registradas na FR007. Dessas lâminas, a aceitabilidade subjetiva de análise não pode exceder variação de 20%. Caso ocorra variação maior que 20%, registra-se uma NC na FR003.

6.4.3. Hemostasia e coagulação

6.4.3.1. Exames de coagulação são controlados através de uma AMC de pool de paciente normais, preparada pelo próprio Laboratório Souza Arêas segundo o ITA002.

6.4.3.2. Sempre que há exames de hemostasia e coagulação in vitro, o colaborador deve analisar o pool como AMC que possui um valor conhecido e verificado, conforme ITA002.

6.4.3.3. Registro e Aprovação

6.4.3.3.1. O valor obtido na análise não deve exceder 10% de CV. Se o resultado for considerado não aceitável, registra-se uma NC na FR026 e investiga-se os seguintes itens:

6.4.3.3.1.1. Estado, estabilidade e calibração do equipamento Clotimer

6.4.3.3.1.2. Validade e estabilidade da AMC de pool de pacientes

6.4.3.3.1.3. Validade e estabilidade dos reagentes de hemostasia e coagulação

6.4.3.3.2. Se o valor obtido estiver dentro da faixa aceitável de 10% de CV, registra-se o resultado na FR026, e dá-se sequência à rotina diária de pacientes.

6.4.4. Tipagem sanguínea

6.4.4.1. O CIQ de tipagem sanguínea é realizado através de dupla observação da corrida de análise.

6.4.4.1.1. Após realizar o procedimento descrito na ITA003 de um paciente da rotina, o colaborador responsável deve ter seu resultado confirmado por um segundo colaborador, que deve ter 100% de concordância sobre a tipagem encontrada.

6.4.4.2. Aprovação e Registro

6.4.4.2.1. Se ambos os colaboradores concordarem com o resultado final obtido após a análise, registra-se suas observações na FR070.

6.4.4.2.2. Caso haja discordância quanto à observação dos resultados registra-se uma NC na FR003, repete-se os exames e investiga-se os seguintes itens:

6.4.4.2.2.1. Validade, estado e estabilidade dos reagentes

6.4.4.2.2.2. Estado e estabilidade da amostra

6.4.5. Coombs Direto e Indireto (TAD e PAI)

6.4.5.1. O CIQ de ambos os Coombs é realizado através de dupla observação de corrida de análise

6.4.5.1.1. Após realizar o procedimento descrito na ITA004 de um paciente da rotina, o colaborador responsável deve ter seu resultado confirmado por um segundo colaborador, que deve ter 100% de concordância sobre o resultado obtido.

6.4.5.2. Aprovação e Registro

6.4.5.2.1. Se ambos os colaboradores concordarem com o resultado final obtido após a análise, registra-se suas observações na FR070.

6.4.5.2.2. Caso haja discordância quanto à observação dos resultados registra-se uma NC na FR003, repete-se os exames e investiga-se os seguintes itens:

6.4.5.2.2.1. Validade, estado e estabilidade dos reagentes

6.4.5.2.2.2. Estado e estabilidade da amostra

6.4.6. Velocidade de Hemossedimentação (VHS)

6.4.6.1. O CIQ de VHS é realizado através de dupla corrida de análise com duas pipetas de Westergreen diferentes e comparação entre as mesmas.

6.4.6.1.1. Ao pipetar a mostra de um paciente, deve-se pipetar também uma segunda corrida de análise desse mesmo paciente em outra pipeta para compará-las uma à outra na primeira e segunda hora de hemossedimentação, segundo ITA005.

6.4.6.1.2. Essa confirmação deve ser feita com no mínimo 10% dos pacientes testados no dia.

6.4.6.2. Aprovação e registro

6.4.6.2.1. Se a confirmação se manter na faixa dos 10% de CV, registra-se os resultados obtidos na FR056.

6.4.6.2.2. Se os 10% de CV não forem atendidos, registra-se uma NC na FR003 e repete-se o exame com novas pipetas.

6.5. URINÁLISE/PARASITOLOGIA:

6.5.1. Urinálise Manual

6.5.1.1. A Urinálise Manual tem sua qualidade controlada diariamente através da reprodutibilidade de uma amostra conhecida fornecida por um representante comercial.

6.5.1.1.1. No começo do dia, o colaborador mergulha uma fita reagente na amostra controle.

6.5.1.1.2. Analisa-se apenas o aspecto bioquímico da amostra para determinação da qualidade da fita reagente utilizada.

6.5.1.1.3. Essa amostra deve ter seus resultados correspondentes aos descritos na bula do controle interno comercial com uma variação aceitável de 10%.

6.5.1.1.4. Após a conferência, a amostra deve ser armazenada adequadamente segundo instruções do fornecedor para que mantenha sua estabilidade para ser utilizada nos dias seguintes

6.5.1.2. Registro e aprovação

6.5.1.2.1. Registra-se o resultado obtido no formulário FR009 – Tiras reagente e FR010 – Sedimento Urinário.

6.5.1.2.2. Se o CV for igual ou menor que 10%, considera-se que a qualidade interna está conforme. Se algum valor exceder o CV de 10%, considera-se não conforme e registra-se uma NC na FR003. Nesse caso, realiza-se os seguintes passos:

6.5.1.2.2.1. Repete-se a análise com uma fita diferente para atestar a estabilidade da amostra controle.

6.5.1.2.2.2. Se for comprovado que a amostra controle perdeu estabilidade, solicita-se a abertura de um novo controle interno.

6.5.1.2.2.3. Se for comprovado que as fitas reagentes perderam estabilidade, solicita-se a troca do kit de análise.

6.5.1.2.2.4. Se ainda assim, a AMC permanecer fora do aceitável de 10%, é registrada uma não conformidade e notifica-se a diretoria para que providências sejam tomadas.

6.5.2. Parasitologia

6.5.2.1. O CIQ de parasitologia é realizado através de dupla observação da corrida de análise.

6.5.2.1.1. Após realizar o procedimento descrito na ITA007 de um paciente da rotina, o colaborador responsável deve ter seu resultado confirmado por um segundo colaborador, que deve ter 100% de concordância sobre os elementos visuais encontrados.

6.5.2.2. Aprovação e Registro

6.5.2.2.1. Se ambos os colaboradores concordarem com o resultado final obtido após a análise, registra-se suas observações na FR011.

6.5.2.2.2. Caso haja discordância quanto à observação dos resultados registra-se uma NC na FR003, repete-se os exames e investiga-se os seguintes itens:

6.5.2.2.2.1. Validade, estado e estabilidade dos reagentes

6.5.2.2.2.2. Estado e estabilidade da amostra

6.5.3. Sangue oculto nas fezes

6.5.3.1. Realiza-se o controle interno do Sangue Oculto nas fezes, a cada lote novo aberto, segundo a ITA008 do procedimento.

6.5.3.2. Amostras Controle

6.5.3.2.1. As amostras controle são fornecidas por representante comercial, atendendo aos requisitos de análise do kit atual em uso.

6.5.3.3. Registro e Aprovação

6.5.3.3.1. O controle é registrado na FR069 e deve corresponder a um resultado de 100%. Valores discordantes representam uma NC, que deve ser registrada na FR003. Caso ocorra uma NC, segue-se os seguintes passos:

6.5.3.3.1.1. Verifica-se validade e estabilidade da AMC

6.5.3.3.1.2. Verifica-se validade e estabilidade do kit

6.5.3.3.2. Valores dentro do aceitável de estão aptos a prosseguir com a rotina de pacientes.

6.6. IMUNOLOGIA:

6.6.1. Testes Imunocromatográficos

6.6.1.1. Realiza-se o controle interno de Testes Imunocromatográficos, a cada lote novo aberto, segundo a ITE de seus respectivos procedimentos. São inclusos nessa instrução os testes abaixo:

6.6.1.1.1. HIV 1 e 2

6.6.1.1.2. HbsAg

6.6.1.1.3. HCV

6.6.1.1.4. β HCG

6.6.1.1.5. Dengue IgG IgM

6.6.1.1.6. Dengue NS1

6.6.1.1.7. Troponina I

6.6.1.2. Amostras Controle

6.6.1.2.1. As amostras-controle são fornecidas por representante comercial ou fornecidas pelo próprio kit, atendendo aos requisitos de análise do kit atual em uso.

6.6.1.3. Registro e Aprovação

6.6.1.3.1. O controle é registrado na FR069 e deve corresponder a um resultado de 100%. Valores discordantes representam uma NC, que deve ser registrada na FR003. Caso ocorra uma NC, segue-se os seguintes passos:

6.6.1.3.1.1. Verifica-se validade e estabilidade da AMC

6.6.1.3.1.2. Verifica-se validade e estabilidade do kit

6.6.1.3.2. Valores dentro do aceitável de estão aptos a prosseguir com a rotina de pacientes.

6.6.2. Testes de Antígenos Sensibilizados

6.6.2.1. Realiza-se o controle interno de Testes de Antígenos Sensibilizados, sempre que houver necessidade segundo a rotina diária seguindo a ITE de seus respectivos procedimentos. São inclusos nessa instrução os testes abaixo:

6.6.2.1.1. PCR

6.6.2.1.2. Látex Fator Reumatóide

6.6.2.1.3. Anti Estreptolisina O (ASLO)

6.6.2.1.4. VDRL

6.6.2.1.5. Hemaglutinação para Chagas

6.6.2.1.6. Brucelose

6.6.2.2. Amostras Controle

6.6.2.2.1. As amostras-controle são fornecidas por representante comercial ou fornecidas pelo próprio kit, atendendo aos requisitos de análise do kit atual em uso.

6.6.2.3. Registro e Aprovação

6.6.2.3.1. O controle é registrado na FR066 e deve corresponder a um resultado de 100%. Valores discordantes representam uma NC, que deve ser registrada na FR003. Caso ocorra uma NC, segue-se os seguintes passos:

6.6.2.3.1.1. Verifica-se validade e estabilidade da AMC

6.6.2.3.1.2. Verifica-se validade e estabilidade do kit

6.6.2.3.2. Valores dentro do aceitável de estão aptos a prosseguir com a rotina de pacientes.

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR003-Não conformidades	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR006- CIQ de Bioquímica	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR007- CIQ de lamina hematológica	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR008- CIQ de hematologia	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

Instrução de Trabalho

Controle Interno da Qualidade - CIQ

Código:
ITS008

Versão:
3.0

Página:
10 de 11

FR009- CIQ de urinálise- tiras reagentes	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR010- CIQ de sedimento urinário	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR011- CIQ das lamínas de parasitologia	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR012- CIQ da coloração de Gram	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR026- CIQ teste de coagulação	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR056- CIQ velocidade de hemossedimentação	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR057- CIQ sangue oculto	Chefe dos setores Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR058- CIQ pesquisa de leucócitos e hemácias nas fezes	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR059- CIQ rotavirus nas fezes	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR060- CIQ Dengue IgG e IgM	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR069- CIQ de testes imunocromatográficos	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR070- CIQ de tipo sanguíneo	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

Instrução de Trabalho

Controle Interno da Qualidade - CIQ

Código:
ITS008

Versão:
3.0

Página:
11 de 11

FR085- CIQ de líquido cefalorraquidiano	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR086- CIQ de líquido pleural	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR087- CIQ de espermograma	Chefe dos setores	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica